의료진 진료 카드 · ASL-078

베타락탐 병력 · 반응부터 구분

과거 반응의 중증도와 원인 약을 확인한다. 피부시험은 병력이 있는 환자의 진단검사다.

세대 이름보다 반응 형태와 곁사슬



본강의 · 검사와 의뢰

병력 없음	베타락탐 사용 전 일률적 피부시험을 권하지 않는다는 강의 설명. 선별시험은 위양성이 많고, 표준 용법 투여 가능하다고 소개.
즉시형 병력	원인 확인 목적: 피부단자시험 후 필요 시 피내시험. Penicillin·cephalosporin 등에 활용, 약제별 민감도 차이. Cefaclor는 UniCAP·피내시험으로 확인 가능.
혈액·유발시험	특이 IgE 검사는 안전·편리하나 제한적 보조수단. 다른 검사로 증명하기 어려운 경우 경구유발시험을 제한적으로 시행; 응급구조약·의료진 대기 필수.
중증 지연형	DRESS·SJS/TEN 등은 일반 즉시형 교차사용과 분리. Patch test는 표준화가 부족하고 소량도 재반응할 수 있어 꼭 필요한 경우 제한적으로 시행한다는 설명.

본강의 · 교차반응 원리

R1 곁사슬	베타락탐 고리 자체보다 약물의 곁사슬 유사성이 중요. 같은 곁사슬을 공유하면 페니실린·세파 계열을 넘어서 교차반응 가능성이 높다.
외래 선택 관행	연자는 복잡한 곁사슬표를 매번 확인하기 어려워 가능하면 베타락탐을 회피하고, 꼭 필요한 경우 전문가 의뢰를 선호한다고 설명. 이를 모든 베타락탐의 절대금기로 쓰지 않는다.

연자 Q&A는 비아나필락시스 병력·R1 차이에 따른 보다 적극적인 사용 접근도 소개했다. 본강의의 보수적 회피 관행과 구분해 다음 쪽의 조건별 답변으로 읽는다.

의료진 진료 카드 · ASL-078

R1 곁사슬 · 공유 약물과 예외

본강의·교재의 공유표를 성분 중심으로 확인한다. 비슷한 약 이름이나 세대만으로 대체하지 않는다.

본강의·교재 · 곁사슬 공유군

Aminobenzyl	Ampicillin · cephalexin · cefaclor · cephradine · loracarbef. 교차 가능성 높음.
Hydroxy-aminobenzyl	Amoxicillin · cefadroxil · cefprozil · cefatrizine. 교차 가능성 높음.
Methoxyimino 계열	Cefotaxime · ceftriaxone · cefepime · cefpodoxime, cefuroxime(유사). 교재는 중~높음으로 표시한 공유군.
Ceftazidime–aztreonam	두 약 사이 R1 공유. Penicillin과 aztreonam 교차는 약 0%로 소개했어도 ceftazidime 원인이면 예외적으로 회피(역도 성립).
Cefazolin 군	Cefazolin · ceftezole(R1 동일), cefazedone(R2 공유). 교재는 중~낮음으로 표시.

교재 · 교차율과 carbapenem

요약 수치	Penicillin–cephalosporin <2%; penicillin/ceph–carbapenem <1%; aminopenicillin–동일 R1 ceph 30~40%. 서로 다른 비교의 수치이며 개별 환자 확률로 단정하지 않는다.
지연형 연구	Imipenem/meropenem 0/204, ertapenem 0/130으로 소개. Carbapenem은 고리가 같아도 penicillin·ceph와 교차가 적다는 설명.
Carbapenem 내부	Meropenem·ertapenem은 pyrrolidine 함유 C2 곁사슬을 공유해 상호 교차 보고. Imipenem은 C2가 달라 대체로 내약한다고 소개.

본강의는 '교차 가능성이 높거나 낮다'와 '100%'를 구분했다. 특히 ceftazidime–aztreonam 예외, 동일·유사 곁사슬, 중증 반응 병력을 확인한 뒤 평가 경로를 정한다.

의료진 진료 카드 · ASL-078

연자 Q&A · 조건별 항생제 선택

김태범 연자가 Q&A에서 소개한 2022 실무지침 접근과 자신의 외래 관행을 구분한 표.

연자 Q&A · Penicillin 병력

비아나필락시스·미확진	과거 제한적 두드러기 등 non-anaphylactic이고 확진되지 않은 penicillin allergy는 cephalosporin을 피부시험 없이 통상 용량 투여할 수 있다는 실무지침을 소개.
Penicillin 아나필락시스	R1이 구조적으로 다른 cephalosporin은 검사·특별 조치 없이 투여할 수 있다는 지침을 소개. 다만 R1 확인이 현실에서 어려워 같은 베타락탐을 가급적 회피하는 것이 가장 안전하다는 연자 관행도 병기.
타 계열 대안	연자는 penicillin·ceph를 제외한 quinolone·macrolide 등으로 변경 가능하다고 답변. 감염 부위별 유효성·내성 판단까지 대신하는 일률 처방표로 쓰지 않는다.

연자 Q&A · Cephalosporin 병력

비아나필락시스	R1이 다른 cephalosporin을 골라 감독하 직접 유발시험(supervised direct challenge)으로 내약성 확인하는 접근을 소개.
아나필락시스·유사 R1	과거 아나필락시스이거나 투여할 약의 곁사슬이 유사하면 ceph 피부시험 후 유발시험 등 신중한 평가를 권고한다고 답변.
세대의 한계	Ceftriaxone 즉시형 두드러기 병력만으로 cefazolin을 자동 금기로 보지 않으며, 세대보다 반응 중증도+R1 유사성이 중요하다고 답변.

검사 결과를 처방 기록에 연결

진단검사 목적

병력에 근거해 원인약을 평가하고, 미리 모든 환자를 선별하는 사전검사와 구분한다.

평가 후 전달

복용 가능한 대체약과 회피약을 카드에 구분해 기록한다. 애매한 사례는 알레르기내과·지역의약품안전센터에 연결한다.